核心精讲·支气管扩张症

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

支气管失去支撑结构(最主要)
↓
肉芽组织修复导致管壁纤维化

一、支扩

1.支扩是支气管管腔持久性扩张、**伴管壁纤维性增厚**的慢性疾病（不能忽略管壁纤维化）

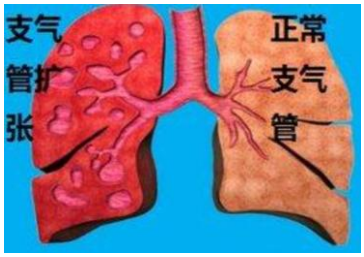




图 10-13　支气管扩张症
肺切面见多数显著扩张的支气管。

2.病因：**支气管肺炎如麻疹或百日咳（最主要）**、慢支炎、肺结核等
小叶性肺炎(很容易波及到段、小支气管)

3.发病机制

慢性感染特别是**反复化脓性炎如支气管肺炎** →**破坏支气管管壁结构**（弹力纤维/平滑肌/软骨等） 肉芽组织修复导致管壁纤维化 支扩发生在段、小支气管，属于传导区（解剖无效腔）、气体都在气道内，当气道失去软骨等限制就会被气体的跨壁压撑大。区别于肺气肿发生在末梢肺组织、气体主要在肺泡内	**支气管失去支撑结构（最主要）**、管壁弹性减弱 慢支炎→肺气肿是破坏终末细支气管、一级呼吸性细支气管管壁结构(没有软骨)→管壁纤维化,管腔狭窄
支气管周围的肺组织因慢性炎症发生纤维化 （形成大量纤维组织）　支气管→纤维化(胶原纤维)	胶原纤维牵拉支气管 特发性肺间质纤维化(影像学上也可看到支气管扩张)
咳嗽→支气管管腔内的压力↑　气道内压力↑	跨壁压（管道内外压力差）↑→气道口径被动扩大

4.典型临床表现：长期咳嗽、**咳大量脓痰**（痰盂）、可咯血



需注意 ttsx：

①支扩咳大量脓痰等阻塞气道→**支扩属于阻塞性通气功能障碍**

（支扩的支气管虽然在扩、但也在阻）
阻塞性通气功能障碍是支扩发病以后的结果
②阻塞性通气障碍不是支扩的发病基础（支扩的发病基础是上述三点导致扩扩扩的）；

阻塞性通气障碍是肺气肿的发病基础